

DFGSO2 / Dentaire 2A

Dentisterie Restauratrice

ED n°2



DFGSO2 – BORDEAUX RONÉOS 2025/2026



Enseignant : KEROUREDAN Olivia	Date et horaire : 14/10/25 16h-17h
Ronéistes :	Référents :
• Demil Alès • Lemsaq El Mehdi	• Bouridane Nour • Boukhatmi Faiza

UE : Dentisterie Restauratrice

ED n°2: Séance de Questions-Réponses (Vrai / Faux)

Question n°1 : La carie dentaire est une maladie infectieuse chronique ?

VRAI. La carie dentaire est considérée comme une **maladie infectieuse** en raison de la **présence de bactéries**, ce qui la rend **transmissible**. On considère qu'elle est transmissible de la mère à l'enfant, l'enfant est encore entrain de développer son écosystème buccale, si la mère lui transmet les bactéries cariogènes, il risque d'être plus sensible à la maladie carieuse. Pour autant sa transmission entre individus adultes reste controversées, on en n'est pas certain hormis chez les patients avec un déficit immunitaire. On la présente comme une maladie transmissible car cela a **un intérêt en terme d'éducation et de prévention**.

De plus, la carie dentaire est une **maladie chronique**, contrairement à une maladie aiguë. Cela signifie qu'elle est **continue tout au long de la vie** du patient et peut durer longtemps sans traitement, il faut gérer différents facteurs comme l'hygiène et l'alimentation pour traiter cette maladie.

Une **lésion carieuse** est due à une déminéralisation de surface de l'émail qui peut être causée par un manque d'hygiène. Au niveau du micro-biome il y a 2 grands types de bactéries responsables de l'acidité : les *Lactobacilles* et les *Streptococcus mutans* (bactéries cariogènes).

Le métabolisme des glucides fermentescibles par des bactéries cariogènes et acidogènes va entraîner la production d'acides responsables du phénomène carieux. La **lésion carieuse** est un symptôme de la **maladie carieuse** (bien distinguer les 2). L'objectif est de gérer tous les facteurs de risques pour éviter la survenue des symptômes et non pas uniquement de cureter les lésions carieuses et les reboucher mais bien prendre en charge le patient dans sa globalité.

Question n°2 : La carie dentaire est principalement causée par des facteurs purement biologiques?

FAUX. Les **facteurs biologiques** liés à la carie dentaire concernent **les bactéries**. La carie se forme à cause de **bactéries cariogènes** qui **métabolisent les sucres**, produisant **des acides** responsables de la **déminéralisation de l'émail** et des **lésions carieuses**.

Les facteurs non biologiques influençant l'apparition des caries incluent

- **Facteurs individuels /comportementaux**, comme le **suivi régulier** chez le dentiste, les **habitudes alimentaires**, l'**hygiène bucco-dentaire**, et la consommation **d'alcool** ou de **drogues**.

- *“Facteurs génétiques : Certaines personnes peuvent avoir une flore bactérienne plus susceptible de causer des caries ou des maladies parodontales.” (n'est pas entièrement convaincu)*

- **Facteurs médicaux** : Des **pathologies** comme le syndrome de Gougerot-Sjögren (maladie auto-immune) la **radiothérapie** qui provoquent une **sécheresse buccale**, ou des **traitements médicaux** comme les antihistaminiques, **antidépresseurs** peuvent entraîner une xérostomie et donc réduire la production de salive, augmentant ainsi le risque de caries.

- **Facteurs socio-économiques** : Le **niveau d'éducation**, l'**accès aux soins** et le **revenu** peut influencer la prévalence des caries.

- **Facteurs intra-oraux :** Les **traitements orthodontiques**, les **malpositions dentaires**, l'**exposition radiculaire**, les **anomalies** de l'émail et des dents, ou des **traitements dentaires inappropriés/restaurations débordantes** effectués par le chirurgien-dentiste qui vont entraîner le risque de survenue de la lésion carieuse car les soins ne sont pas idéalement adaptés.
- **Facteurs protecteurs :** L'utilisation de **fluor** dans l'hygiène bucco-dentaire, une bonne hygiène, le **chewing-gum** sans sucre (qui stimule la production de salive), le **scellement des sillons**, et des **agents antibactériens comme le gluconate de chlorhexidine** aident à réduire la charge bactérienne et à prévenir les caries.

Question 3 : Une diminution du pH local en dessous de 5,5 est responsable de la déminéralisation ?

VRAI. L'**émail** est un tissu relativement **résistant aux attaques acides**, avec un pH critique estimé à environ **5,5**. Cependant, l'**ajout d'ions fluorures** peut abaisser ce pH critique à environ **4,5**. Cela signifie que, grâce au fluor, il faut des attaques acides plus fortes pour déminéraliser l'émail. Le fluorure s'incorpore dans la matrice amélaire et rend l'émail plus résistant au phénomène de déminéralisation.

Question 4 : La prévention de la carie repose uniquement sur l'utilisation de fluorure ?

FAUX. Pour **réduire le risque de caries**, **trois éléments essentiels** doivent être abordés avec le patient :

- **fluor**
- **brossage des dents**
- **alimentation**

Hors fluorure, on peut retrouver comme cité plus tôt les **gommes à mâcher sans sucre** qui permettent de stimuler le débit salivaire et avoir un effet protecteur, la **chlorhexidine** dans les bains de bouches (des études ont montré qu'il y aurait un intérêt de cette molécule pour limiter le risque carieux mais **ce n'est pas l'agent à privilégier**), le **xylitol**, le **fluorure diamine d'argent** utilisé dans le cadre de la prévention de la carie radiculaire mais aussi pour les patients avec qui on a une coopération très difficile pour stopper l'évolution des lésions carieuses (carie du biberon), le **CPP-ACP** (phosphopeptide de caséine et phosphate de calcium amorphe) sous forme de crème dentaire après le brossage des dents. L'avantage est que ça permet le rechargement de l'environnement buccal en phosphate et calcium pour avoir une bonne reminéralisation. Le phosphopeptide de caséine est dérivé de protéines de lait, donc **il ne doit pas être prescrit aux patients allergiques ou intolérants au lactose**.

L'hygiène bucco-dentaire seule ne suffit pas, il est aussi crucial de **contrôler l'alimentation**. La **consommation de sucre**, en particulier **lorsqu'elle est prolongée** tout au long de la journée, est problématique. Bien que le sucre soit présent dans de nombreux aliments, une surconsommation continue **empêche la salive de neutraliser l'acidité**, maintenant ainsi un **environnement défavorable pour les dents**.

Un exemple fréquent est celui de patients ayant une bonne hygiène bucco-dentaire, mais qui souffrent tout de même de caries en raison de grignotages fréquents.

Il est donc important de discuter des habitudes d'hygiène bucco-dentaire et alimentaires dès la première consultation, idéalement à l'aide d'un journal diététique.

Question 5 : Les programmes de prévention collective sont plus efficaces lorsqu'ils ciblent uniquement les enfants ?

FAUX. Les programmes de prévention doivent s'adresser à **tous les groupes d'âge : enfants, adolescents, adultes notamment chez les femmes enceintes, mais aussi les personnes âgées et personnes en situation de handicap**. Le plus connu pour les enfants et adolescents est M'T dents. Donner des conseils d'hygiène à certains adultes peut être délicat, souvent la solution est de passer par les enfants pour sensibiliser par la même occasion les parents. La **prévention est essentielle**.

Des initiatives de **prévention collective** sont mises en place dans des établissements comme les **EHPAD, crèches, écoles et structures pour personnes en situation de handicap**. La collaboration dans ces environnements est cruciale pour identifier des solutions et améliorer la santé dentaire des patients.

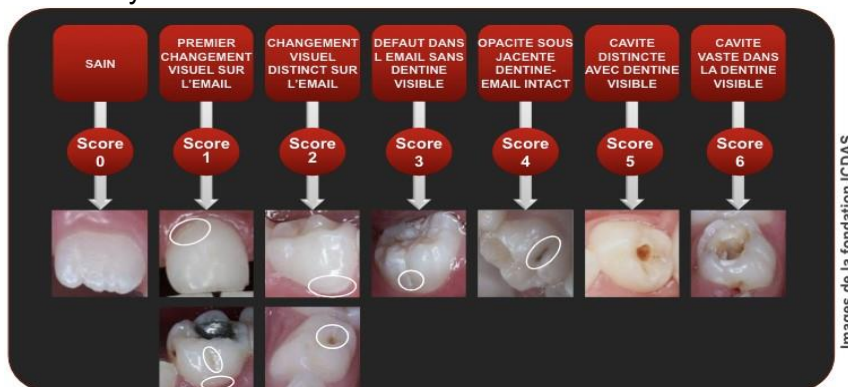
Petit aparté : réponse à une question d'un étudiant concernant l'importance de la prise en charge de la santé bucco-dentaire chez l'enfant bien que ses dents de lait soient destinées à partir. Une non prise en charge entraînerait plusieurs complications comme le développement d'un microbiote très cariogène et lors de l'éruption des dents permanentes il peut y avoir des lésions carieuses prématurées, infections qui vont affecter les germes de la dent permanente et entraîner des potentielles hypominéralisations, cela peut aussi générer un déficit esthétique (problématiques psycho-sociales, altération de la qualité de vie, douleurs). Il est important d'avoir cette prise en charge globale pour sa santé générale, il faudra gérer tous les facteurs de risques et que cette gestion soit acquise avant l'éruption des dents permanentes. Il faut considérer avec autant d'importance les dents lactéales que les dents définitives car cela va conditionner l'état bucco-dentaire à l'âge adulte.

Question 6 : Le diagnostic de la carie repose principalement sur un examen tactile de la dent ?

FAUX. Ce qui est primordial sur le **diagnostic de la carie** est l'**examen visuel** (classification ICDAS). L'examen tactile est complémentaire, utilisé dans certaines situations car cela peut poser problème et créer des dommages irréversibles car l'émail est fragile et certains praticiens peuvent forcer avec la sonde. Si on veut utiliser une sonde, on utilise la sonde parodontale (bout mousse/rond) de manière très modérée.

Question 7 : La classification ICDAS comprend six stades de sévérité des lésions carieuses ?

FAUX. Il y a **7 stades**



Question 8 : Une sonde de préférence à bout fin et pointu, peut être utilisée en complément de l'examen visuel ?

FAUX. Pendant longtemps, on a négligé le potentiel de **reminéralisation** de certaines lésions, en particulier les **lésions carieuses non cavitaires**. Une petite **tache blanchâtre** indique une lésion qui peut se reminéraliser complètement. Cependant, si l'on utilise une **sonde** sur cette surface hypominéralisée, cela **peut endommager l'émail et créer une microcavitation**, favorisant l'infiltration de bactéries et le **développement d'une carie dentaire**.

Il est donc préférable de se concentrer sur l'examen visuel. Si un sondage est nécessaire, il convient d'utiliser une sonde à bout mousse/rond pour détecter un éventuel ramollissement, sans jamais piquer la lésion. Ce sujet divise les praticiens.

Question 9 : Les examens radiographiques avec incidence rétro-coronaire sont adaptés pour évaluer la profondeur des lésions carieuses ?

VRAI. En dentisterie, la **radiographie panoramique** est l'examen standard pour **évaluer l'état bucco-dentaire** du patient, notamment en orthodontie et pour observer la pousse des dents de sagesse. **Les scanners**, quant à eux, permettent d'obtenir une **reconstruction en 3D**, ce qui aide à évaluer la proximité des dents de sagesse par rapport à des structures anatomiques, comme le nerf alvéolaire inférieur, et à analyser les risques associés à une intervention chirurgicale

Lors des examens au fauteuil, des radiographies plus détaillées sont réalisées. Les deux types les plus courants sont :

- **Examen rétro-alvéolaire** : Il permet d'examiner la **couronne et la racine** des dents, essentiel en **endodontie** pour évaluer l'anatomie et la taille des racines, ainsi que pour détecter d'éventuelles infections au niveau du péri-apex.
- **Examen rétro-coronaire (adapté pour les faces proximales)** : Le patient mord sur des capteurs pour obtenir une image des **couronnes supérieure et inférieure**. Cet examen est utile pour **diagnostiquer les lésions carieuses** et déterminer leur **profondeur**. Par exemple chez un patient jeune sans lésions à l'examen clinique on peut l'utiliser car c'est peu irradiant et obtient les 2 secteurs (à droite et à gauche) en même temps et on peut évaluer si oui ou non on a des caries interproximales qui passerai inaperçu.

Question 10 : Le DIAGNOdent est un outil qui utilise la fluorescence pour évaluer la profondeur des lésions carieuses ?

VRAI. C'est un outil qui utilise la fluorescence. **Les outils de diagnostic** sont nombreux :

- La **transillumination par fibre optique**
- La **fluorescence**
- "la conductance électrique, la tomographie optique et les ultrasons" sont moins utilisés

(

En complément selon l'article 2:

On a également la diode électroluminescente, elle est considérée comme peu fiable car elle détecte toutes les anomalies comme des caries. Elle n'est pas commercialisée. On a également la tomographie optique qui permet la production d'une image microstructurale, c'est un des moyens les plus efficace.

Pour finir on a également les ultrasons qui présentent des résultats prometteurs)

Question 11 : Les lésions carieuses initiales apparaissent principalement sous forme de tâches blanches visibles à l'œil nu ?

VRAI. Une lésion carieuse apparaît **blanchâtre** en raison de l'**hypominéralisation de l'émail**, qui devient poreux. Ces microporosités se remplissent de **fluides** comme la salive, l'eau, mais aussi l'air **modifiant l'indice de réfraction**. Lorsque la **lumière** traverse cette zone, elle est **déviée** dans diverses directions, créant **un halo lumineux**, ce qui donne **l'illusion d'une lésion brillante**. On peut remplacer ces microporosités par une résine qui va les infiltrer qui va avoir l'indice de réfraction de la matrice amélaire naturel.

Question n°12: Les lésions carieuses initiales se développent souvent dans les zones difficiles à nettoyer, comme les points de contact interdentaires?

VRAI. Cela fait référence aux sites de cario-susceptibilité, comme mentionné dans la classification SISTA et la classification ICDAS. Les lésions carieuses initiales se forment souvent dans des zones de **point de contact**, ainsi que dans les **sillons occlusaux ou vestibulaires/palatins** et **fosses**, qui sont toutes des zones difficiles à nettoyer. De plus, les **collets** dentaires, au niveau cervical, peuvent également être des zones à risque, car la gencive peut accumuler de la plaque dentaire si l'hygiène bucco-dentaire est insuffisante.

Question n°13 : La couche superficielle des lésions carieuses initiales est plus résistante à la déminéralisation que le corps de la lésion ?

VRAI. Dans les lésions carieuses initiales, la couche superficielle est effectivement plus résistante à la déminéralisation que le corps de la lésion. Cela s'explique par le fait qu'il existe une **couche hyper minéralisée à la surface**.

On a le **pouvoir reminéralisant de la salive** qui va agir. La salive contient beaucoup d'éléments minéraux comme le phosphate et le calcium qui participent à la reminéralisation naturelle conforme des dents. Quand on a une chute du pH, on a l'acidité qui va dissoudre en surface l'émail. La salive va immédiatement pouvoir exercer son pouvoir tampon et aussi via l'action des éléments reminéralisant venir reminéraliser la surface dentaire. On suppose que cette **lésion est hyper minéralisée en surface grâce au pouvoir de la salive**.

Question n°14 : Les fluorures sont inefficaces pour reminéraliser les lésions carieuses initiales ?

FAUX. Les **fluorures** sont **efficaces** pour la reminéralisation des lésions carieuses initiales. On peut également prescrire du **verniss fluoré** à appliquer au fauteuil pour aider cette reminéralisation (2 à 4 fois par an)

Sans oublier aussi les autres alternatives comme le **CPP-ACP**, les **particules de nano hydroxyapatite**, les **phosphosilicates**, les **phosphates calciques** et le **xylitol** que l'on peut proposer aux patients pour la reminéralisation.

Elle explique que c'est important de connaître ces noms-là et de savoir dans quelle situation les prescrire.

Question n°15 : La zone sombre et la zone translucide sont deux des quatre zones caractéristiques des lésions carieuses initiales ?

VRAI. Les **quatre zones** d'une lésion carieuse, de la surface à la profondeur, sont : la zone **superficielle**, la zone du **corps de la lésion**, la zone **sombre** et la zone **translucide**.

Question n°16 : La technique de scellement thérapeutique est indiquée pour les lésions carieuses non cavitaires ou micro cavitaires ?

VRAI. Le scellement thérapeutique se fait avec de la résine de viscosité fluide pour qu'elle puisse aller au niveau des sillons par exemple des molaires au niveau postérieur (blocage mécanique). Une autre technique, le CVI, propose des propriétés différentes. Contrairement à la résine, il est lui bioactif, il va se charger en ions minéraux et favoriser la reminéralisation des lésions.

La technique de **scellement thérapeutique** peut maintenant être utilisée pour **traiter des lésions micro cavitaires**. Certains articles ont montré des cas de jeunes patients présentant des microcavités au niveau de l'émail, mais avec une grande lésion carieuse au niveau dentinaire. Dans ces articles, des scellements thérapeutiques ont été appliqués et ont suivi les patients tous les trois mois, constatant qu'il n'y avait pas d'évolution de la lésion carieuse grâce à ce scellement thérapeutique.

Cependant, cela comporte des risques, car il n'est pas garanti que le patient revienne régulièrement pour des contrôles, ni que le scellement soit parfaitement hermétique. En cas de perte d'étanchéité, cela peut entraîner une infiltration et la progression de la lésion carieuse. Il est donc important de réserver le scellement thérapeutique aux lésions carieuses débutantes, et non aux lésions trop évoluées.

Le scellement fonctionne bien lorsqu'il est réalisé dans de bonnes conditions. Par exemple, sous digue et avec un protocole de collage rigoureux, ce qui permet de sceller hermétiquement la lésion carieuse. Ainsi, en scellant la lésion, les bactéries n'ont plus accès à leurs sources nutritionnelles et se retrouvent isolées, ce qui diminue leur métabolisme, voire l'arrête complètement. Cela conduit à une stabilisation de la lésion carieuse, ce qui est particulièrement intéressant, car c'est une **approche non invasive**. Il est néanmoins essentiel que le patient assure un **bon suivi** et que l'intervention soit effectuée dans des **conditions optimales**.

Question n°17 : L'utilisation régulière d'un dentifrice fluoré à 1000 ppm est une mesure préventive efficace contre les caries ?

VRAI. Pour un patient standard avec un **faible risque carieux**, on considère qu'un dentifrice à **1000 ppm** offre une protection préventive efficace contre les lésions carieuses. Pour les patients à **risque carieux élevé**, il est recommandé d'utiliser des dentifrices contenant entre **1400/1500 ppm – 2500/3000** de fluor, car ces concentrations sont mieux adaptées à leur situation. Il y a aussi ceux à **5000 ppm** par exemple chez les patients ayant un risque carieux très sévère, il s'agit d'un dentifrice relativement cher et non remboursé, les patients concernés l'utilisent matin et soir jusqu'à la fin du tube et repassent ensuite sur un dentifrice autour de **1400/1500 ppm**, les patients sont conseillés de refaire une cure au dentifrice 5000 ppm tous les 6 mois.

Question n°18 : Les dentifrices fluorés à haute concentration (5000 ppm) sont plus efficaces pour arrêter la progression des lésions carieuses ?

VRAI. Les dentifrices fluorés à haute concentration (5000 ppm) sont prescrits à l'hôpital dans certains cas. Par exemple, pour un **jeune patient polycarieux** avec une hygiène bucco-dentaire défavorable. Dans ces situations, on travaille à la fois sur l'éducation thérapeutique et sur le renforcement de l'apport en fluor grâce à ces dentifrices.

Ils peuvent également être utiles pour des **patients dépendants**, ceux ayant reçu une **radiothérapie** (reste un cas particulier car on peut leur faire des gouttières avec application de gel fluoré quotidien) ou des patients souffrant de certaines **pathologies** tel que la diminution du débit salivaire. Ils peuvent être utiles pour des **patients à risque élevé**, comme ceux ayant des problèmes de toxicomanie, qui présentent souvent de nombreuses caries, notamment au niveau des collets. Dans ces cas, on cherche à renforcer la minéralisation ou à ralentir l'évolution des caries en attendant de réaliser les soins nécessaires.

Ces dentifrices à haute concentration sont autorisés **à partir de 16 ans**, car avant cet âge, ils peuvent entraîner une fluorose. La fluorose se manifeste cliniquement par différents degrés : cela peut aller de simples petites taches blanches sur les dents jusqu'à des atteintes sévères avec des altérations d'états de surface, des taches brunes, marrons voire noires. Les cas les plus sévères sont notamment retrouvés chez des patients originaires de villages de Sénégal et d'Afrique du Nord, où l'eau de consommation est très chargée en fluor provoquant alors des atteintes dentaires sévères.

Elle répond à une question posée par un étudiant, qui demande si l'utilisation d'un dentifrice 5000 ppm est nocif et pourquoi est-ce que l'on ne le prescrit pas à tous les patients ? Elle explique le fait que les dentifrice 5000 ppm sont dans un premier temps des dentifrices non remboursés par la sécurité sociale, qu'ils sont plus coûteux que les dentifrices classiques et qu'ils n'ont pas d'intérêt chez un patient qui présente un risque carieux faible. Pour les patients avec risques carieux élevés, une bonne hygiène bucco-dentaire et l'utilisation d'un dentifrice entre 1500 et 3000 ppm est suffisant.

Question n°19 : Le scellement thérapeutique réduit considérablement la progression des caries dans les puits et fissures des molaires ?

VRAI. Le **scellement thérapeutique** permet de **traiter les lésions carieuses**, que ce soit sur de l'émail sain ou dans des lésions carieuses initiales, qu'elles soient non cavitaires ou cavitaires.

Question n°20 : Le fluorure de diamine d'argent permet de traiter les tissus déminéralisés sans préjudice esthétique ?

FAUX. Les caractéristiques du **fluorure de diamine d'argent** est qu'il provoque des inflammations au niveau de la gencive, une **coloration noire des dents** en raison de la présence d'argent avec un vrai risque de tatouages gingivaux dont il faut faire attention. Ce traitement est intéressant pour les enfants non-coopérants ou pour certains patients en situation de handicap, car il permet d'**éviter des actes chirurgicaux** difficiles à réaliser. En appliquant ce produit, on peut stopper l'évolution des lésions, bien que cela ne soit **pas esthétique**.

Ce traitement est surtout **utilisé lorsque d'autres options ne sont pas possibles**, comme dans le cas de la carie du biberon. Cela concerne des enfants qui sont allaités ou qui prennent le biberon de manière prolongée, souvent jusqu'à 4, 5 ou 6 ans, ce qui peut causer des dégâts considérables sur leurs dents de lait, les rendant complètement cariées jusqu'à la racine.

Question n°21 : Les scellements thérapeutiques sont utilisés uniquement pour les lésions carieuses non cavitaires ?

FAUX. Les scellements thérapeutiques peuvent être utilisés pour des **lésions cavitaires**. Le scellement thérapeutique peut être réalisé jusqu'au stade ICDAS 4. On considère que les classes 1 et 2 sont non cavitaires, tandis que les classes 3 et 4 correspondent à des microcavités avec des lésions débutantes, où le scellement thérapeutique peut être indiqué.

Question n°22 : L'éducation à l'hygiène alimentaire fait partie de la phase prophylactique de l'intervention minimale ?

VRAI. L'éducation à l'hygiène alimentaire fait partie de la **phase prophylactique** (= phase de prévention), c'est-à-dire tout ce qui se fait en **amont de la phase restauratrice/ micro-chirurgicale**. Cela inclut l'éducation à l'hygiène alimentaire et l'éducation bucco-dentaire. On retrouve aussi ce concept d'éducation thérapeutique pour la prise en charge de maladie chronique comme le diabète.

Question n°23 : L'infiltration résineuse est une méthode micro-invasive pour traiter les lésions non cavitaires des faces lisses ?

VRAI. L'**infiltration résineuse** est une technique qui correspond à la technique d'"érosion/infiltration" qui permet de restaurer les propriétés optiques d'un émail hypominéralisé. Elle consiste à utiliser une résine ayant un indice de réfraction similaire à l'émail pour remplacer l'eau dans les microporosités, déshydratant ainsi la lésion hypominéralisée. Cela restaure les propriétés optiques naturelles de la dent, lui redonnant son apparence esthétique d'origine.

Elle est particulièrement utile pour traiter les lésions carieuses initiales, qui apparaissent souvent sous forme de taches blanches en raison des microporosités liées à l'hypominéralisation. Cette technique est également utilisée pour les cas d'hypominéralisation molaire et incisive, connues sous le nom de **MIH**, qui sont fréquentes chez les enfants et les adolescents et peuvent entraîner des préjudices esthétiques importants.

Il faut distinguer les déminéralisations qui sont liées aux processus carieux et qui surviennent après l'éruption des dents, des hypominéralisations qui surviennent pendant la phase d'odontogenèse qui peuvent être causées par la fluorose ou des traitements médicamenteux pris pendant l'enfance.

En cas de **fluorose**, qui résulte d'une intoxication au fluor pendant l'enfance, des taches blanches symétriques peuvent apparaître sur les dents en développement. Cela ne pose

pas de risque de surdosage en fluor chez les adultes, mais cela affecte les enfants dont les dents sont encore en formation.

Il existe aussi des cas d'**hypominéralisation d'origine traumatique**, par exemple lorsqu'un enfant de 4/5 ans se blesse en tombant et impacte ses incisives. Même si l'impact ne semble pas grave sur le moment, il peut léser les germes sous-jacents des dents définitives, entraînant des anomalies de l'émail qui se traduisent par des taches blanches, brunes ou orangées. Lorsque la dent définitive fait son éruption, on remarque une hypominéralisation au niveau de la couronne dentaire liée à l'impact de la racine de la dent de lait au niveau de la couronne pendant la phase d'amélogénèse. Ces hypominéralisations sont assez fréquentes. Cela peut avoir un impact esthétique significatif et affecter la vie sociale de l'enfant. L'infiltration résineuse est une thérapie intéressante car elle permet de restaurer l'esthétique de ces dents à minima.

Question n°24 : L'approche par "gouttière" est une technique utilisée pour le traitement des lésions carieuses proximales ?

VRAI. Différentes stratégies existent. Lorsque deux dents côte à côte présentent une lésion carieuse au niveau du point de contact, on peut délabrer la crête marginale de la dent pour accéder à la lésion carieuse en proximal. Ensuite, un système de matriçage est mis en place pour restaurer la dent.

Cependant, d'autres approches moins invasives permettent de préserver la **crête marginale**, qui est essentielle à la **solidité de la dent**. La perte d'une crête marginale affaiblit la dent, et si deux crêtes sont perdues, la dent devient trop susceptible de se fracturer. Dans ce cas, un recouvrement cuspidien, comme un overlay en céramique, est recommandé.

Pour éviter d'éliminer la crête marginale, il existe des stratégies qui consistent à accéder à la lésion soit par la **surface vestibulaire**, en attendant la lésion au niveau du point de contact, soit par la **fosse marginale**, en accédant transversalement à la lésion carieuse proximale. Cette approche est appelée "tunnel". Cette méthode est moins courante et nécessite de bonnes conditions de visibilité, généralement sous microscope.

Question n°25 : La phase de suivi dans l'intervention minimale vise à prévenir les récurrences de caries et à contrôler les facteurs de risque ?

VRAI. Les aspects **préventif** et **suivi** sont les deux points les plus importants dans la prise en charge d'un patient, même avant de considérer les interventions restauratrices. En effet, si le patient ne gère pas correctement ses facteurs de risque initiaux et ne bénéficie pas

d'un bon suivi, les efforts de restauration seront voués à l'échec, car il faudra constamment reprendre les traitements. Il ne faut pas laisser son patient sans suivi régulier.

La professeure a partagé plusieurs documents, des liens de site jugés intéressants : CariesCare International (reprend les indications basées sur ICDAS, basés sur les 4 dimensions de la prise en charge des patients : la détection des lésions carieuses, la prise de décision, les thérapeutiques adaptées, et réévaluer/redéterminer les facteurs de risques et assurer le suivi du patient), et GC Dental (manuel de dentisterie minimalement invasive, différents cas de figure de patients, poser le diagnostic, établir le plan de traitement en fonction des facteurs de risques individuels, outils de prévention/détection) + Système CAMBRA (important de connaître les grands systèmes d'évaluation des risques carieux, connaître les noms, le cariogramme, indicateurs du risque carieux et facteurs de risque, identifier les risques protecteurs).

